



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

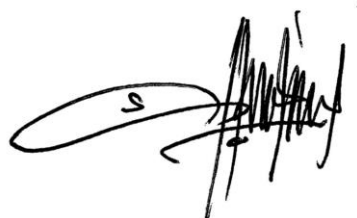
PANDUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN STAF

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 1083.5/I-PND/DIR/XII/2025

Tentang
Panduan Perencanaan Kebutuhan Staf

Penanggung Jawab :



(Susan Rahmawati, S. Sos)

Disetujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP)

Ditetapkan Oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Perencanaan Kebutuhan Staf dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Perencanaan Kebutuhan Staf ini, mutu sumber daya manusia di Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 01 Desember 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN
PERENCANAAN KEBUTUHAN STAF

Pengarah:

1. Dr. dr. Aslichah, M. Kes., AFP
2. dr. Ari Putriani, Sp. PK
3. dr. Resti Lestantini, M. Kes

Penyusun:

1. Susan Rahmawati, S. Sos
2. drg. Endy Wira Pradana, MMRS
3. Puput Sekar Nariratih, Amd. Keb
4. Dwi Novianti, Amd. AK., S. Kes
5. Nur Rizkiah Amalia

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

TIM PENYUSUN..... iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

PERATURAN DIREKTUR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan..... 1

BAB II RUANG LINGKUP..... 3

BAB III TATA LAKSANA 4

 3.1 Dasar Perencanaan Staf..... 4

 3.2 Penyusunan Pola Ketenagaan 4

 3.3 Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Kerja 13

 3.4 Cara Perhitungan Kebutuhan Tenaga Keperawatan 17

BAB IV PENUTUP 23

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1 Dasar Perhitungan dan Penetapan Kualifikasi Staf..... 5



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 1083.5/I-PND/DIR/XII/2025**

TENTANG

PANDUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN STAF

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit Prima Husada diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
 - b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 062.1/I-PER/DIR/I/2018 tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Staf sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Perencanaan Kebutuhan Staf.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
 9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1001.1/I-PDM/DIR/XI/2025 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PANDUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN STAF**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Rumah Sakit menetapkan perencanaan kebutuhan staf rumah sakit yang berdasar atas perencanaan strategis dan perencanaan tahunan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit

Pasal 2

Rumah Sakit menetapkan prosedur tentang pola ketenagaan dan kebutuhan jumlah staf sesuai dengan yang dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan staf, panduan penempatan dan penempatan kembali staf.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam perencanaan kebutuhan staf di rumah sakit ini yakni:

1. Perencanaan Kebutuhan Staf
2. Pengelompokan Staf
3. Pemenuhan Kebutuhan Staf
4. Penugasan
5. Rotasi, Mutasi dan Alih Fungsi Staf
6. Pengembangan dan Pelatihan Staf
7. Monitoring dan Evaluasi
8. Dokumentasi dan Pelaporan

BAB III TATA LAKSANA

Pasal 4

Dalam perhitungan kebutuhan staf di rumah sakit langkah awal yang harus dilakukan yakni kepala unit menetapkan persyaratan Pendidikan, kompetensi dan pengalaman setiap staf di unit masing-masing untuk dapat memberikan asuhan kepada pasien.

Pasal 5

Perencanaan kebutuhan di rumah sakit dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 Desember 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 1083.5/I-PND/DIR/XII/2025
TENTANG PANDUAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN STAF

PANDUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN STAF

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia atau yang sering disebut dengan Personalia adalah suatu bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan pemenuhan sumber daya manusia khususnya Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang sesuai dengan standar profesi dan mempunyai kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan. Seleksi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) tersebut harus dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan dari setiap Satuan Kerja yang ada di rumah sakit.

Untuk dapat menunjang pencapaian dalam hal pelayanan maka proses Manajemen Sumber Daya Manusia (Sumber Daya Manusia) diperlukan sebuah pedoman kerja sehingga didapatkan hasil yang baik dan bermutu. Pelayanan yang bermutu di rumah sakit akan membantu setiap staf untuk dapat berkarya sesuai dengan profesi, pendidikan serta kemampuan yang dimiliki, membantu proses pelayanan pada pasien di rumah sakit sehingga pasien yang datang berobat ke rumah sakit merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, yang berarti pula customer tersebut nantinya akan sebagai sarana dalam mempromosikan rumah sakit. Keuntungan lain jika pasien cepat sembuh adalah mereka dapat segera kembali mencari nafkah untuk diri dan keluarga.

Dalam manajemen sumber daya manusia juga dibahas mengenai perhitungan dan perencanaan tenaga kerja yang mana hal ini merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai sasaran melalui strategi pengembangan kontribusi staf di masa depan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Panduan perencanaan kebutuhan staf di rumah sakit ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyusunan, perencanaan, dan penetapan kebutuhan tenaga secara terstruktur, sistematis, dan berbasis pada analisis beban kerja, kompetensi, serta jenis pelayanan di setiap unit kerja.

Panduan ini juga dapat dijadikan acuan bagi pimpinan rumah sakit, kepala bidang dan kepala ruang dalam melakukan pengelolaan kebutuhan tenaga yang tepat sesuai dengan jumlah, jenis dan kompetensi guna untuk mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang maksimal.

-
2. Tujuan Umum
 - a. Tercukupinya kebutuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di tiap-tiap unit kerja.
 - b. Dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk pelayanan di tiap unit.
 3. Tujuan Khusus
 - a. Memberikan panduan bagi kepala bidang dan kepala ruang untuk menyusun kebutuhan tenaga.
 - b. Memberikan panduan perhitungan kebutuhan di masing-masing unit kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perencanaan kebutuhan staf di rumah sakit ini yakni:

1. Perencanaan Kebutuhan Staf
Hal ini meliputi identifikasi serta Analisa kebutuhan tenaga berdasarkan:
 - a. Jenis dan cakupan pelayanan di rumah sakit
 - b. Kompleksitas pelayanan dan perkembangan teknologi
 - c. Regulasi dan standar keprofesian yang berlaku
 - d. Analisa beban kerja
 - e. Rencana strategis dan pengembangan rumah sakit
2. Pengelompokan Staf
Seluruh tenaga kerja yang termasuk dalam perencanaan staf yakni meliputi:
 - a. Tenaga medis
 - b. Tenaga keperawatan
 - c. Tenaga kesehatan lainnya
 - d. Tenaga non kesehatan
3. Pemenuhan Kebutuhan Staf
Dalam hal ini mencakup rekrutmen, seleksi, penempatan dan orientasi tenaga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang disyaratkan.
4. Penugasan
Penugasan meliputi pengaturan terkait penempatan tenaga kerja berdasarkan dengan kompetensi, kewenangan klinis, serta kebutuhan unit kerja, system penjadwalan kerja (shift) dan penugasan khusus.
5. Rotasi, Mutasi dan Alih Fungsi Staf
Hal ini meliputi pengaturan perpindahan tenaga kerja antar unit, rotasi berkala, serta alih fungsi sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan kompetensi dan efisiensi pelayanan.
6. Pengembangan dan Pelatihan Staf
Meliputi perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi serta pengembangan karir dan kompetensi tenaga kerja.
7. Monitoring dan Evaluasi
Meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kecukupan, distribusi, kinerja, serta efektivitas pemanfaatan SDM secara berkala.
8. Dokumentasi dan Pelaporan
Hal ini meliputi pencatatan seluruh proses perencanaan, pemenuhan, dan evaluasi SDM sebagai bukti pelaksanaan dan pemenuhan standar akreditasi.

Ruang lingkup ini berlaku untuk seluruh unit kerja yang ada di rumah sakit dan menjadi acuan dalam pengelolaan staf yang terintegrasi, berkesinambungan serta berorientasi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

BAB III

TATA LAKSANA

3.1 Dasar Perencanaan Staf

Dalam perhitungan kebutuhan staf di rumah sakit langkah awal yang harus dilakukan yakni kepala unit menetapkan persyaratan Pendidikan, kompetensi dan pengalaman setiap staf di unit masing-masing untuk dapat memberikan asuhan kepada pasien. Kepala unit dalam menghitung kebutuhan staf mempertimbangkan beberapa factor sebagai berikut:

- a. Misi rumah sakit.
- b. Populasi pasien yang dilayani dan kompleksitas serta kebutuhan pasien.
- c. Layanan diagnostik dan klinis yang disediakan rumah sakit.
- d. Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan.
- e. Peralatan medis yang digunakan untuk pelayanan pasien.

Rumah sakit juga mematuhi peraturan serta perundang-undangan tentang syarat Pendidikan, keterampilan dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan oleh staf.

Perencanaan kebutuhan staf disusun secara kolaboratif oleh kepala unit dengan mengidentifikasi jumlah, jenis, serta kualifikasi staf yang dibutuhkan. Dimana perencanaan tersebut ditinjau secara berkelanjutan dan diperbarui sesuai kebutuhan.

Pada proses perencanaan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan kebutuhan juga mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini:

- a. Terjadinya peningkatan jumlah pasien atau kekurangan staf di satu unit sehingga dibutuhkan rotasi staf dari satu unit ke unit lain.
- b. Pertimbangan permintaan staf untuk rotasi tugas berdasarkan nilai-nilai budaya atau agama dan kepercayaan.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
- d. Perencanaan staf dipantau secara berkala dan diperbarui sesuai kebutuhan.

3.2 Penyusunan Pola Ketenagaan

1. Mekanisme Penyusunan Pola Ketenagaan

- a) Melakukan observasi tentang jumlah dan kualifikasi kebutuhan karyawan dari setiap unit.
- b) Memastikan jumlah dan kualifikasi karyawan dari setiap unit apakah sudah sesuai.
- c) Mencocokkan jumlah yang dimiliki oleh setiap karyawan dengan persyaratan kualifikasi pada pola ketenagaan.
- d) Mencocokkan jumlah yang dimiliki oleh setiap unit dengan jumlah karyawan staf pada pola ketenagaan.
- e) Jika hasil mencocokkan kualifikasi dan jumlah karyawan telah sesuai maka kebutuhan karyawan dalam suatu unit telah dinyatakan sesuai kebutuhan.

2. Dasar Perhitungan Dalam Penetapan Kualifikasi Staf

Tabel 3.2.1 Dasar Perhitungan dan Penetapan Kualifikasi Staf

Unit	Kualifikasi	Dasar Perhitungan
Direktur	1. KualifikasiDokter 2. Pendidikan : a. S2 Magister Management b. Rumah Sakit 3. Pelatihan ACLS 4. Kompetensi a. Mempunyai pengalaman kerja di Rumah Sakit Minimal 2 Tahun	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023
Kepala Bidang Pelayanan Medis	1. Kualifikasi Dokter / Perawat / Bidan 2. Pendidikan a. Dokter Umum/ Spesialis b. Perawat / Bidan 3. Pelatihan ACLS 4. Kompetensi a. Mempunyai Pengalaman Manajerial di Rumah Sakit Minimal 2 Tahun dan 5 tahun untuk non dokter b. Pengalaman Klinik di Layanan Kesehatan	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023
Kepala Bidang Keperawatan	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1 Keperawatan 3. Pelatihan Manajemen Bangsal 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 3 tahun	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023
Kepala Bidang Penunjang Medis	1. Kualifikasi Sarjana 2. Pendidikan S1 Administrasi rumah sakit atau bidang pelayanan kesehatan 3. Pelatihan a. Manajemen Rumah Sakit b. Mutu dan Keselamatan Pasien 4. Kompetensi Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023
Kepala Bidang Umum	1. Kualifikasi Sarjana 2. Pendidikan S1 Semua Jurusan / S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit 3. Pelatihan Manajemen 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023
Kepala Instalasi	1. Kualifikasi Dokter 2. Pendidikan	Analisa Beban Kerja Permendagri

Unit	Kualifikasi	Dasar Perhitungan
Rawat Inap	Pendidikan Dokter Spesialis 3. Pelatihan a. ACLS b. Manajemen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 2 tahun	Nomor 12 Tahun 2008
Kepala Instalasi Rawat Jalan	1. Kualifikasi Dokter 2. Pendidikan Pendidikan Dokter Spesialis 3. Pelatihan a. ACLS b. Manajemen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 2 tahun	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Kepala Instalasi IGD	1. Kualifikasi Dokter 2. Pendidikan Pendidikan Dokter Spesialis 3. Pelatihan a. ACLS b. Manajemen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 2 tahun	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Kepala Instalasi IKO	1. Kualifikasi Dokter Anestesi 2. Pendidikan Dokter Anestesi 3. Pelatihan a. ACLS b. Manajemen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 2 tahun	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Kepala Instalasi ICU	1. Kualifikasi Dokter Anestesi 2. Pendidikan Dokter Anestesi 3. Pelatihan a. ACLS b. Manajemen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 2 tahun	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Kepala Instalasi Radiologi	1. Kualifikasi Dokter Spesialis Radiologi 2. Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi 3. Pelatihan ACLS 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Kepala	1. Kualifikasi	Analisa Beban

Unit	Kualifikasi	Dasar Perhitungan
Instalasi Laboratorium	Dokter Spesialis PK 2. Pendidikan Dokter Patologi klinik 3. Pelatihan Manajemen rumah sakit 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Instalasi Gawat Darurat (IGD)	1. Kualifikasi a. Perawat b. Bidan 2. Pendidikan a. S1 Keperawatan b. DIII Keperawatan c. DIII Kebidanan d. DIV Kebidanan 3. Pelatihan a. BTCLS / ACLS b. PPGD 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 1 tahun	Depkes 2005
Instalasi Kamar Operasi (IKO)		
Penata Anestesi	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan a. ACLS b. Sertifikasi Anestesi 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 2 tahun	Depkes 2005
Instrumen	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan a. BLS / ACLS b. Sertifikasi Instrumen 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 2 tahun	Depkes 2005
Onloop	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan BLS / ACLS 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 1 tahun	Depkes 2005
Recovery	1. Kualifikasi	Depkes 2005

Unit	Kualifikasi	Dasar Perhitungan
Room	Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan a. BLS / ACLS b. PPGD 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 5. 1 tahun	
Intensive Care Unit (ICU)	1. Kualifikasi Perawat 2. Pendidikan S1/DIII Keperawatan 3. Pelatihan ACLS 4. Pelatihan ICU minimal 1 bulan 5. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang kesehatan minimal 1 tahun	Depkes 2005
Instalasi Rawat Inap (IRNA)	1. Kualifikasi a. Perawat b. Bidan 2. Pendidikan a. S1 Keperawatan b. DIII Keperawatan c. DIII Kebidanan 3. Pelatihan a. BLS b. BTLS c. ACLS d. PPGD 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 1 tahun	Depkes 2005 dan PMK No 56 Tahun 2014
Instalasi Rawat Jalan (IRJA)	1. Kualifikasi Perawat / Bidan 2. Pendidikan a. S1 Keperawatan / Kebidanan b. DIII Keperawatan / Kebidanan c. S1 Perawat Gigi 3. Pelatihan a. BLS b. BTLS c. ACLS d. PPGD / APN / CTU 4. Kompetensi Mempunyai Pengalaman dibidang keperawatan minimal 1 tahun	Depkes 2005
Rehab Medik	1. Kualifikasi a. Fisioterapis b. Terapis Wicara 2. Pendidikan	Depkes 2005

Unit	Kualifikasi	Dasar Perhitungan
	a. DIII / DIV Fisioterapis b. DIII / DIV Terapis Wicara 3. Pelatihan - 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	
Farmasi		
Apoteker	1. Kualifikasi Apoteker 2. Pendidikan S1 Apoteker 3. Pelatihan Peracikan Obat 4. Kompetensi Teknik dispensing dan peracikan obat	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Tenaga Vokasi Farmasi	1. Kualifikasi a. DIII/S1 Farmasi 2. Pendidikan a. DIII/S1 Farmasi 3. Pelatihan Penyiapan Obat 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Admin Farmasi	1. Kualifikasi a. DIII/S1 Farmasi b. S1 Lainnya 2. Pendidikan a. S1 Lainnya 3. Pelatihan Tidak ada pelatihan khusus 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Apoteker Gudang Farmasi	1. Kualifikasi Apoteker 2. Pendidikan S1 Apoteker 3. Pelatihan Peracikan Obat 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Tenaga Vokasi Gudang Farmasi	1. Kualifikasi a. SMK Farmasi b. DIII/S1 Farmasi 2. Pendidikan a. SMK Farmasi b. DIII/S1 Farmasi 3. Pelatihan Penyiapan Obat 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Radiologi	1. Kualifikasi Radiografer 2. Pendidikan DIII Radiologi	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008

Unit	Kualifikasi	Dasar Perhitungan
	3. Pelatihan Anatomi tubuh 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	
Laboratorium	1. Kualifikasi Analis 2. Pendidikan DIII Analis Kesehatan 3. Pelatihan Plebotomi 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Gizi	1. Kualifikasi Ahli Gizi 2. Pendidikan DIII / DIV Gizi 3. Pelatihan HACCP 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Dapur	1. Kualifikasi SMA / SMK 2. Pendidikan SMA / SMK 3. Pelatihan Penjamah Makanan 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Rekam Medis	1. Kualifikasi Perekam Medik 2. Pendidikan DIII Perekam Medik 3. Pelatihan - Filling dan Assembling - Pengelolaan Rekam Medik 4. Kompetensi - Menguasai ICD 10 - Menguasai ICD 9 - Menguasai gsfik Barber Jhonson	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Pendaftaran	1. Kualifikasi - Ahli Madya - SMA 2. Pendidikan - DIII RMIK - SMA/SMK 3. Pelatihan Service Excellent 4. Kompetensi - Pengalaman kerja 1 tahun di bidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
CSSD &	2. Kualifikasi	Analisa Beban

Unit	Kualifikasi	Dasar Perhitungan
Laundry	a. Perawat b. SMA / SMK 3. Pendidikan a. S1/DIII Keperawatan b. SMA 4. Pelatihan a. BHD b. Sterilisasi Dasar 5. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Asuransi Center	1. Kualifikasi Coding dan Asuransi Jaminan 2. Pendidikan a. DIII RMIK b. SMA / SMK 3. Pelatihan a. Assembling dan Filling b. Pengelolaan Rekam Medik 4. Kompetensi a. Pengalaman kerja 1 tahun di bidangnya b. Menguasai ICD 10 c. Menguasai ICD 9 d. Menguasai grafik Barber Jhonson	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Kasir	1. Kualifikasi a. S1 Ekonomi / Akuntansi b. SMA / SMK 2. Pendidikan a. S1 Ekonomi / Akuntansi b. SMA / SMK 3. Pelatihan Manajemen keuangan 4. Kompetensi Pengalaman minimal 2 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1. Kualifikasi a. SMK b. D3 Elektromedis 2. Pendidikan SMA/Sederajat 3. Pelatihan Manajemen 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
IT SIMRS	1. Kualifikasi Sarjana 2. Pendidikan Sarjana Komunikasi/ IT 3. Pelatihan Manajemen SIMRS 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008

Unit	Kualifikasi	Dasar Perhitungan
Security	1. Kualifikasi SMA / SMK 2. Pendidikan SMA / SMK 3. Pelatihan Gada Pratama 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Driver	1. Kualifikasi SMA / SMK 2. Pendidikan SMA / SMK 3. Pelatihan SIM A atau SIM B/B1 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Cleaning Service	1. Kualifikasi SMP / SMA 2. Pendidikan Minimal SMP atau SMA Sederajat 3. Pelatihan PPI dasar 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Gudang Umum	1. Kualifikasi SMP / SMA 2. Pendidikan Minimal SMP atau SMA Sederajat 3. Pelatihan - 4. Kompetensi Tidak ada kompetensi khusus	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
SDM	1. Kualifikasi Manajemen SDM 2. Pendidikan S1 Psikologi atau S1 Lainnya 3. Pelatihan a. Penyusunan ABK b. Struktur Skala Upah c. Jam Kerja Karyawan d. Analisa Pendidikan dan Pelatihan 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
Sekretaris	1. Kualifikasi Administrasi perkantoran 2. Pendidikan S1 Administrasi perkantoran atau S1 Lainnya 3. Pelatihan - 4. Kompetensi Pengalaman minimal 1 tahun dibidangnya	Analisa Beban Kerja Permendagri Nomor 12 Tahun 2008

3.3 Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Kerja

Perencanaan kebutuhan dirumah sakit dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan staf meliputi:

1. *Workload Indicators of Staffing Need / WISN (Depkes RI 2005)*

Metode perhitungan *Workload Indicators of Staffing Need* (WISN) adalah metode perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja nyata, waktu kerja tersedia, serta standar waktu untuk menyelesaikan setiap jenis kegiatan pekerjaan.

Adapun langkah-langkah perhitungan WISN adalah sebagai berikut:

a) Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT)

Waktu kerja tersedia dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Waktu Kerja Tersedia} = \{A - (B + C + D + E)\} \times F$$

Keterangan:

A = Hari Kerja

B = Cuti tahunan

C = Pendidikan dan Pelatihan

F = Hari Libur Nasional

E = Ketidakhadiran Kerja / Libur

F = Waktu Kerja

Contoh:

- Hari kerja : 312 hari
- Cuti : 12 hari
- Libur Nasional : 16 hari
- Pelatihan : 5 hari
- Ketidakhadiran : 5 hari

$$\text{WKT} = (312 - 12 - 16 - 5 - 5) \times 8 = 274 \times 8 = 2192 \text{ jam/tahun}$$

b) Menentukan unit kerja dan jenis tenaga

Untuk menetapkan unit kerja dan kategori staf maka data dan informasi yang dibutuhkan yakni:

- 1) Struktur organisasi rumah sakit dan uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
- 2) Keputusan direktur rumah sakit tentang pembentukan unit kerja struktural dan fungsional, misalnya: Komite Medik, Komite Pengendalian Mutu RS, Komite PPI, Komite PKRS.
- 3) Data staf berdasarkan pendidikan yang bekerja di tiap unit.
- 4) Standar profesi, pelayanan dan standar prosedur operasional di tiap unit.

Contoh:

- Rawat Inap : Perawat
- Rawat Jalan : Perawat dan Bidan
- IGD : Perawat dan Bidan
- ICU / HCU : Perawat
- IKO : Perawat

c) Menyusun kegiatan pokok

Kegiatan pokok adalah kupulan berbagai jenis kegiatan sesuai standar pelayanan dan standar prosedur operasional (SPO) untuk menghasilkan pelayanan yang dilaksanakan oleh staf kesehatan dengan kompetensi tertentu.

Langkah ini untuk memudahkan dalam menetapkan beban kerja masing-masing kategori staf, perlu disusun kegiatan pokok serta jenis kegiatan pelayanan yang berkaitan langsung / tidak langsung dengan pelayanan kesehatan.

Contoh:

- Asuhan keperawatan
- Pemberian obat
- Observasi pasien
- Dokumentasi

d) Menentukan rata-rata waktu (Norma Waktu)

Rata-rata waktu / norma waktu adalah suatu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan pokok oleh masing-masing kategori staf pada tiap unit kerja. Kebutuhan waktu untuk menyelesaikan kegiatan sangat bervariasi dengan dipengaruhi standar pelayanan, SPO, sarana dan prasarana yang tersedia.

Rata-rata waktu atau norma waktu ini ditetapkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama bekerja dan kesepakatan Bersama.

Contoh:

- Pemberian obat : 10 menit/pasien
- Observasi : 5 menit/pasien

e) Menghitung Standar Beban Kerja (SBK)

Standar beban kerja adalah volume atau kuantitas beban kerja selama satu tahun per kategori staf yang disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan (waktu rata-rata) dan waktu kerja tersedia yang dimiliki oleh masing-masing kategori staf.

Adapun rumus perhitungan standar beban kerja adalah sebagai berikut:

Standar Beban Kerja	=	$\frac{\text{Waktu Kerja tersedia (WKT)}}{\text{Rata-rata Waktu per Kegiatan}}$
---------------------	---	---

Contoh:

SBK = 2192 jam ÷ 10 menit = 131.520 menit ÷ 10 menit = 13.152 kegiatan/tahun

f) Menghitung kebutuhan tenaga untuk kegiatan pokok

Untuk menghitung kebutuhan tenaga untuk kegiatan pokok dapat menggunakan rumus:

Jumlah Tenaga	=	$\frac{\text{Total Kegiatan}}{\text{Standar Beban Kerja}}$
---------------	---	--

g) Menghitung factor kelonggaran (*Allowance Factor*)

Hal ini bertujuan untuk memperoleh jenis kegiatan dan kelonggaran

kebutuhan tiap waktu kategori untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang tidak terkait langsung atau dipengaruhi tinggi rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok atau pelayanan. Berikut beberapa contoh dari factor kelonggaran adalah sebagai berikut:

- Jumlah kegiatan dalam suatu hari, minggu dan bulan.
- Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan.
- Rapat, penyusunan laporan kegiatan dan lain sebagainya.

Selama pengumpulan data kegiatan penyusunan standar beban kerja mulai dilakukan pencatatan tersendiri apabila ditemukan kegiatan yang tidak dapat dikelompokkan atau sulit dihitung beban kerjanya karena berkaitan dengan pelayanan pada pasien untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber data penyusunan factor kelonggaran tiap kategori staf.

Setelah factor kelonggaran tiap staf tersebut diperoleh, langkah selanjutnya adalah menyusun standar kelonggaran dengan melakukan perhitungan. Berikut rumus perhitungan factor kelonggaran:

Standar Kelonggaran	=	$\frac{\text{Rata-rata waktu kelonggaran}}{\text{Waktu Kerja Tersedia (WKT)}}$
---------------------	---	--

h) Menghitung kebutuhan tenaga akhir
Perhitungan kebutuhan staf akhir ini tujuannya yakni diperolehnya jumlah dan jenis kategori staf per unit kerja sesuai dengan beban kerja selama 1 tahun.

Sumber data yang dibutuhkan untuk perhitungan kebutuhan ini meliputi:

- 1) Data yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya yakni:
 - Waktu kerja tersedia
 - Standar beban kerja
 - Standar kelonggaran masing-masing kategori staf
- 2) Kuantitas kegiatan pokok tiap unit kerja selama kurun waktu satu tahun.

Kuantitas kegiatan pokok disusun berdasarkan berbagai data kegiatan pelayanan yang telah dilaksanakan di tiap unit kerja rumah sakit selama kurun waktu 1 tahun.

Perhitungan kebutuhan staf dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

Kebutuhan Staf	=	$\frac{\text{Kuantitas Kegiatan Pokok}}{\text{Standar Beban Kerja (SBK)}} + \text{Standar Kelonggaran}$
----------------	---	---

i) Interpretasi hasil
Interpretasi hasilnya yakni sebagai berikut:

- Rasio = 1 → Kebutuhan ideal
- Rasio < 1 → Kekurangan tenaga
- Rasio > 1 → Kelebihan tenaga

2. ABK (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008)
Analisis Beban Kerja (ABK) adalah metode untuk menentukan jumlah

kebutuhan tenaga berdasarkan volume pekerjaan, norma waktu, dan jam kerja efektif dalam suatu jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008.

Komponen dalam perhitungan metode Analisis Beban Kerja (ABK) yakni:

- Volume Kerja
- Norma Waktu
- Jam Kerja Efektif

Adapun tahapan perhitungan metode Analisis Beban Kerja (ABK) adalah sebagai berikut:

a) Menyusun uraian tugas

Uraian tugas disini yakni melakukan identifikasi semua kegiatan yang dilakukan dalam satu jabatan atau unit kerja.

Contoh:

- Rekam medis : assembling, coding, filling
- Farmasi : penyiapan e-tiket, peracikan obat, KIE

b) Menentukan volume kerja

Volume kerja yang dimaksud adalah total kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun.

Contoh:

- Kunjungan pasien : 10.000/tahun
- Penyiapan obat non racikan : 5.892/tahun

c) Menentukan norma waktu

Norma waktu adalah standar waktu atau rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu kegiatan.

Contoh:

- Pendaftaran pasien : 5 menit
- Penyiapan obat non racikan : 5 menit

d) Menghitung beban kerja (Isi kerja)

Perhitungan beban kerja menggunakan rumus:

$\text{Beban Kerja} = \text{Volume Kerja} \times \text{Norma Waktu}$
--

Hasil beban kerja di konversikan dari menit ke jam.

Contoh:

Beban Kerja = $10.000 \times 5 \text{ menit} = 50.000 \text{ menit} = 50.000/60 = 833 \text{ jam/tahun}$

e) Menghitung kebutuhan tenaga

Selanjutnya menentukan kebutuhan tenaga yang merupakan rumus utama ABK yakni:

$\text{Kebutuhan Tenaga} = \frac{\text{Total Beban Kerja}}{\text{Jam Kerja Efektif}}$

Contoh:

Kebutuhan Tenaga = $833 \div 1.300 = 0,64 = 1 \text{ orang}$

- f) Rekapitulasi beban kerja
Tahap ini dilakukan untuk merekap atau menjumlah seluruh beban kerja dari semua tugas dalam jabatan atau unit tersebut.
- g) Analisis kebutuhan dan Interpretasi hasil
Dari hasil perhitungan kebutuhan tenaga yang telah dilakukan lalu bisa dilakukan analisa dengan cara membandingkan hasil perhitungan kebutuhan dengan tenaga yang saat ini tersedia.
Dari tahap ini akan dapat diketahui apakah jumlah tenaga unit tersebut telah sesuai atau belum.
Interpretasi hasil bisa dilihat dengan:
- > kebutuhan : kekurangan tenaga
 - = kebutuhan : ideal
 - < kebutuhan : kelebihan tenaga

3.4 Cara Perhitungan Kebutuhan Tenaga Keperawatan

1. Pengelompokan Unit Kerja di Rumah Sakit
Kebutuhan tenaga keperawatan (perawat dan bidan) harus memperhatikan unit kerja yang ada di RS Prima Husada. Secara umum pengelompokan unit kerja di unit keperawatan adalah sebagai berikut:
- a) Instalasi Rawat Inap
 - b) Instalasi Rawat Jalan
 - c) Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - d) Instalasi Kamar Operasi (IKO)
 - e) Intensive Care Unit (ICU)
2. Model Pendekatan Dalam Perhitungan Kebutuhan Tenaga Keperawatan
Model perhitungan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga adalah:

a) Instalasi Rawat Inap (IRNA 2C)

- 1) Tingkat ketergantungan pasien

No	Kategori	Rata Jml Px/Hari	Jumlah Jam Perawat/Hari	Jumlah Jam Perawatan/Ruang/Hari
1	Askep Minimal	0	2	0
2	Askep Sedang	4	3,08	12,32
3	Askep Berat	4	4,15	16,6
4	Askep Maksimal	0	6,16	0
Jumlah		8		28,92

Dengan acuan:

- Jam efektif perawat : 7 jam
- Jumlah hari minggu (1 tahun) : 52 hari
- Cuti : 12 hari
- Hari besar (1 tahun) : 14 hari
- Jumlah hari kerja efektif : 286 hari
- Koreksi : 25%

2) Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$= \frac{\text{Jumlah jam perawatan/ruang/hari}}{7} = \frac{28,92}{7} = 4,131$$

- 3) Koreksi loss day (dalam 1 tahun)

$$= \{(Jumlah\ hari\ minggu + cuti + hari\ besar) \div 286\} \times Jumlah\ perawat\ tersedia$$

$$= \{(52 + 12 + 14) \div 286\} \times 4,131$$

$$= 1,126\ orang$$
- 4) Tugas non keperawatan 25%

$$= \frac{Jumlah\ tenaga\ keperawatan + loss\ day \times 25}{100} = \frac{4,131 + 1,126 \times 25}{100}$$

$$= \frac{131,425}{100} = 1,314\ orang$$
- 5) Jumlah tenaga yang dibutuhkan

$$= 4,131 + 1,126 + 1,314 = 6,571 = 6 + 1\ Karu = 7\ orang$$

b) Instalasi Rawat Jalan

- 1) Tingkat jumlah pasien
 Dasar perhitungan untuk instalasi rawat jalan yakni:
 - Jumlah pasien/hari : 450 pasien (berdasarkan data kunjungan tahun 2025)
 - Rata-rata perawatan : 15 menit
 - Jam efektif perawat : 7 jam
 - Jumlah hari minggu (1 tahun) : 52 hari
 - Cuti : 12 hari
 - Hari besar (1 tahun) : 14 hari
 - Jumlah hari kerja efektif : 286 hari
 - Koreksi : 15%
- 2) Hitung total waktu pelayanan per hari
 Total waktu (menit) = Jumlah pasien x Waktu per pasien ÷ 60 menit

$$= 450 \times 15 = 5955 \div 60 = 112,5\ jam$$
- 3) Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$= \frac{Jumlah\ jam\ perawatan/ruang/hari}{7} = \frac{112,5}{7} = 16,071$$
- 4) Koreksi loss day (dalam 1 tahun)

$$= \{(Jumlah\ hari\ minggu + cuti + hari\ besar) \div 286\} \times Jumlah\ perawat\ tersedia$$

$$= \{(52 + 12 + 14) \div 286\} \times 16,071$$

$$= 4,383\ orang$$
- 5) Tugas non keperawatan 15%

$$= \frac{Jumlah\ tenaga\ keperawatan + loss\ day \times 15}{100} = \frac{16,071 + 4,38 \times 15}{100}$$

$$= \frac{306,81}{100} = 3,068\ orang$$
- 6) Jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan

$$= 16,071 + 4,383 + 3,068 = 23,52 = 24 + 1\ karu = 25\ orang$$

c) Instalasi Gawat darurat (IGD)

Standar Ketenagaan perawat di IGD adalah:

1) Tingkat ketergantungan pasien

No	Kategori	Rata Jml Px/Hari	Jumlah Jam Perawat/Hari	Jumlah Jam Perawatan/Ruang/Hari
1	Askep Minimal	18	2	36
2	Askep Sedang	11	3,08	33,88
3	Askep Berat	2	4,15	8,30
4	Askep Maksimal	0	6,16	0
Jumlah		3		78,18

Dengan acuan:

- Jam efektif perawat : 7 jam
- Jumlah hari minggu (1 tahun) : 52 hari
- Cuti : 12 hari
- Hari besar (1 tahun) : 14 hari
- Jumlah hari kerja efektif : 286 hari
- Koreksi : 25%

2) Jumlah perawat yang dibutuhkan
$$= \frac{\text{Jumlah jam perawatan/ruang/hari}}{7} = \frac{78,18}{7} = 11,16$$

3) Koreksi loss day (dalam 1 tahun)
$$= \{(\text{Jumlah hari minggu} + \text{cuti} + \text{hari besar}) \div 286\} \times \text{Jumlah perawat tersedia}$$
$$= \{(52 + 12 + 14) \div 286\} \times 11,16$$
$$= 2,86 \text{ orang}$$

4) Tugas non keperawatan 25%
$$= \frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan} + \text{loss day} \times 25}{100} = \frac{11,16 + 2,86 \times 25}{100}$$
$$= \frac{350,25}{100} = 3,502 \text{ orang}$$

5) Jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan
$$= 11,16 + 2,86 + 3,502 = 17,525 = 18 \text{ orang} + 1 \text{ karu} = 19 \text{ orang}$$

Standar Ketenagaan Bidan di IGD adalah:

6) Tingkat ketergantungan pasien

No	Kategori	Rata Jml Px/Hari	Jumlah Jam Perawat/Hari	Jumlah Jam Perawatan/Ruang/Hari
1	Askep Minimal	4	2	8
2	Askep Sedang	3	3,08	9,24
3	Askep Berat	0	4,15	0
4	Askep Maksimal	0	6,16	0
Jumlah		7		17,24

Dengan acuan:

- Jam efektif perawat : 7 jam
- Jumlah hari minggu (1 tahun) : 52 hari
- Cuti : 12 hari
- Hari besar (1 tahun) : 14 hari
- Jumlah hari kerja efektif : 286 hari
- Koreksi : 25%

- 7) Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$= \frac{\text{Jumlah jam perawatan/ruang/hari}}{7} = \frac{17,24}{7} = 2,46$$
- 8) Koreksi loss day (dalam 1 tahun)

$$= \{(\text{Jumlah hari minggu} + \text{cuti} + \text{hari besar}) \div 286\} \times \text{Jumlah perawat tersedia}$$

$$= \{(52 + 12 + 14) \div 286\} \times 2,46$$

$$= 0,67 \text{ orang}$$
- 9) Tugas non keperawatan 25%

$$= \frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan} + \text{loss day} \times 25}{100} = \frac{2,46 + 0,67 \times 25}{100}$$

$$= \frac{18,25}{100} = 0,1825 \text{ orang}$$
- 10) Jumlah tenaga bidan yang dibutuhkan

$$= 2,46 + 0,67 + 0,1825 = 3,3125 = 4 \text{ orang}$$
- 11) Jumlah tenaga keseluruhan yang dibutuhkan

$$= 19 \text{ perawat} + 4 \text{ bidan} = 23 \text{ orang}$$

d) Instalasi Kamar Operasi (IKO)

- 1) Dasar perhitungan di unit IKO adalah:
- Jumlah dan jenis operasi
 - Jumlah kamar operasi
 - Pemakaian kamar operasi pada hari kerja
 - Tugas perawat di kamar operasi terdiri dari instrumen, sirkular (orang/tim)
 - Ketergantungan pasien
 - Operasi Khusus (± 3 jam per satu operasi)
 - Operasi Besar (± 2 jam per satu operasi)
 - Operasi Sedang (± 1 jam per satu operasi)
 - Operasi Kecil (± 1 jam per satu operasi)
- 2) Perhitungan Kebutuhan
 Perhitungan tenaga instalasi kamar operasi rata-rata operasi dalam 1 hari = 6 pasien/hari, yang terdiri dari:

Jenis Operasi	Jumlah
Khusus	1
Besar	5
Sedang	0
Kecil	0
Jumlah	6

Dengan acuan:

- Jam efektif perawat : 7 jam
- Jumlah hari minggu (1 tahun) : 52 hari
- Cuti : 12 hari
- Hari besar (1 tahun) : 14 hari
- Jumlah hari kerja efektif : 286 hari
- Koreksi : 25%

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah jam operasi/hari} \times \text{jumlah operasi}) \times \text{jumlah perawat dalam tim} + 1 \text{ (cadangan)} \div \text{jam kerja efektif/hari} \\
 &= \{(3 \times 1) + (2 \times 5)\} \times 3 + 1 \div 7 \\
 &= (3 + 10) \times 3 + 1 \div 7 \\
 &= 13 \times 3 + 1 \div 7 \\
 &= 5,7 = 6 \text{ orang}
 \end{aligned}$$

3) Faktor Koreksi

a. Hari libur/cuti/hari besar (loss day)

$$\begin{aligned}
 &= \{(\text{Jumlah hari minggu} + \text{cuti} + \text{hari besar}) \div 286\} \times \text{Jumlah perawat tersedia} \\
 &= \{(52 + 12 + 14) \div 286\} \times 6 \\
 &= 1,64 = 2 \text{ orang}
 \end{aligned}$$

b. Tugas non keperawatan 25%

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah tenaga perawat} + \text{loss day} \times 25}{100} = \frac{5 + 2 \times 25}{100} \\
 &= \frac{175}{100} = 1,75 = 2 \text{ orang}
 \end{aligned}$$

4) Perhitungan Tenaga Ruang Penerimaan dan recovery Room

Ruang penerimaan : 30 menit

Recovery room : 3 jam

Rumus:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Jumlah jam} \times \text{jumlah operasi jam kerja efektif} \div \text{hari} \\
 &= 3 \times 6 \div 7 = 2,6 = 3 \text{ orang}
 \end{aligned}$$

5) Jumlah tenaga yang dibutuhkan

$$\begin{aligned}
 &= 6 + 2 + 2 + 3 = 13 \text{ orang}
 \end{aligned}$$

e) Intensive Care Unit (ICU)

1) Tingkat ketergantungan pasien

No	Kategori	Rata Jml Px/Hari	Jumlah Jam Perawat/Hari	Jumlah Jam Perawatan/Ruang/Hari
1	Askep Minimal	0	2	0
2	Askep Sedang	0	3,08	0
3	Askep Berat	8	4,15	33,2
4	Askep Maksimal	3	6,16	18,48
Jumlah		11		51,68

Dengan acuan:

- Jam efektif perawat : 7 jam
- Jumlah hari minggu (1 tahun) : 52 hari
- Cuti : 12 hari
- Hari besar (1 tahun) : 14 hari
- Jumlah hari kerja efektif : 286 hari
- Koreksi : 25%

2) Jumlah perawat yang dibutuhkan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah jam perawatan/ruang/hari}}{7} = \frac{51,68}{7} = 7,38
 \end{aligned}$$

-
- 3) Koreksi loss day (dalam 1 tahun)
 $= \{(\text{Jumlah hari minggu} + \text{cuti} + \text{hari besar}) \div 286\} \times \text{Jumlah perawat tersedia}$
 $= \{(52 + 12 + 14) \div 286\} \times 7,38$
 $= 2,01 = 2 \text{ orang}$
- 4) Tugas non keperawatan 25%
 $= \frac{\text{Jumlah tenaga keperawatan} + \text{loss day} \times 25}{100} = \frac{7,38 + 2,01 \times 25}{100}$
 $= \frac{234,83}{100} = 2,34 = 2 \text{ orang}$
- 5) Jumlah tenaga yang dibutuhkan
 $= 7,38 + 2,01 + 2,34 = 11,73 = 12 \text{ orang}$

BAB IV

PENUTUP

Panduan Perencanaan Kebutuhan Staf disusun dalam rangka memberikan acuan bagi Rumah Sakit dalam melakukan perencanaan kebutuhan staf yang bermutu, amam, efektif dengan mengutamakan keselamatan pasien. Oleh karena itu setiap rumah sakit diharapkan dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam buku pedoman ini dan dapat mengembangkannya sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 Desember 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes